

07 - Syndrome de Gougerot-Sjögren - Pr. Essadouni

(0:03 - 0:43)

Alors bonjour, toujours dans le cadre des connectivites et des maladies auto-immunes, le deuxième cours qu'on va voir ensemble est celui d'un syndrome de Goujraud-Jograin. Et pour illustrer le syndrome de Goujraud-Jograin, on va commencer par cette observation clinique qui est celle d'une femme de 40 ans qui a été admise en consultation pour sécheresse butale et aussi une sensation de sable dans les yeux. Cette symptomatologie évolue depuis 4 mois chez cette malade.

(0:44 - 1:16)

Dans les antécédents de cette patiente, on trouve une polyarthrite rhumatoïde sous méthotrexate et un traitement par fluoxétine pour une dépression. L'examen clinique chez cette patiente trouve des lèvres qui s'en sèchent et des caries dentaires. Quelle diagnostic évoquez-vous à ce stade? Une patiente qui a un syndrome sec oculaire et butale et qui est sous méthotrexate pour une polyarthrite rhumatoïde et qui est sous fluoxétine pour la dépression.

(1:17 - 1:45)

Alors, le syndrome sec chez cette patiente peut être lié soit à un syndrome de Goujraud-Jograin ou alors à des effets secondaires de la fluoxétine. On sait que les antidépresseurs peuvent engendrer une sécheresse des muqueuses également. Alors, quel bilan demandez vous? Bien sûr, pour le syndrome sec ophtalmologique, il faut explorer la fonction lacrymale au moyen de deux tests.

(1:45 - 2:04)

Le premier, c'est le test de Schirmer qui évalue l'hyposécration lacrymale. On verra tout à l'heure comment. Et le deuxième, c'est le test de verre au verre de lysamine qui va se localiser ou alors se déposer au niveau des lésions corneillennes.

(2:06 - 2:25)

Le test de Schirmer qui explore l'hyposécration lacrymale. Alors, le principe, c'est qu'on va mettre sur le cul de sac inférieur ces bandelettes graduées. On va voir au bout de cinq minutes l'imbibition par les larmes.

(2:25 - 2:45)

Alors, si c'est inférieur à 5 millimètres, ça veut dire qu'il y a un syndrome sec. Alors là, vous avez le test au verre de lysamine. On va mettre du verre de lysamine au niveau conjonctival et on va voir que ce produit va se déposer au niveau des muqueuses qui sont lésées.

(2:45 - 3:04)

Ça témoigne d'une agressivité et d'une gravité de ce syndrome sec parce qu'il y aura des ulcérations corneillennes qui vont se produire. Alors, exploration de la xérostomie. Tout d'abord, on va faire la mesure du flux salivaire.

(3:04 - 3:14)

On va donner un crachoir au patient. On va lui demander de cracher. Si au bout de 15 minutes, il crache moins de 1,5 ml, ça veut dire que c'est un syndrome sec.

(3:16 - 3:38)

Sinon, en fait, c'est pas sinon, c'est que la biopsie des glandes salivaires accessoires. C'est l'examen primordial pour quantifier et évaluer l'infiltration de la glande par des lymphocytes et des plasmocytes qui vont s'organiser en nodules. Et on va voir combien de nodules existent en 4 mètres carrés de surface glandulaire.

(3:39 - 3:55)

Sur le plan pratique, on va avoir recours à la biopsie des glandes salivaires et la mesure du flux salivaire. On ne fait pas au niveau de l'hôpital de façon fréquente. Alors, voilà comment on fait pour la biopsie des glandes salivaires.

(3:55 - 4:15)

Ça se passe au niveau de la face interne de la lèvre inférieure. On va mettre un anesthésique de l'alidocaïne, par exemple. Et puis, juste après, on va faire une incision pour faire sortir la glande salivaire et la lire en histologie.

(4:16 - 4:31)

Et ça va nous donner le stade de l'infiltration glandulaire. Et ça va nous permettre de faire le diagnostic du syndrome de Gougeron. Alors, pour la biopsie des glandes salivaires accessoires, vous avez une notation histologique caractéristique.

(4:32 - 4:56)

Et le stade 3 ou le stade 4 sont caractéristiques ou alors spécifiques du diagnostic du syndrome de Gougeron avec les autres manifestations cliniques. Alors, le stade 3, c'est un foyer de 50 nodules, par exemple, par 4 millimètres carrés. Et le stade 4, c'est plusieurs foyers par millimètre carré.

(4:57 - 5:15)

Et donc, ceux-ci, ces deux stades sont nécessaires pour faire le diagnostic du syndrome de Gougeron. Donc, soit le stade 4, soit le stade 3. Les autres stades ne sont pas caractéristiques. Voilà comment se présentent les modules ou alors les focus scores.

(5:15 - 5:28)

Là, vous avez un focus score. Et là, vous avez donc plusieurs focus scores par 4 millimètres carrés de surface histologique. Et donc, c'est un stade 4 de Chisholm.

(5:31 - 5:44)

Alors, là, vous avez des critères d'inclusion. Quand on suspecte un syndrome de Gougeron, vous avez les critères subjectifs. Ici, ce que vous demandez au patient ou alors ce que le patient rapporte.

(5:44 - 7:47)

Est-ce qu'il a des yeux secs? Est-ce qu'il a une sécheresse au niveau de la bouche de piquant? Est-ce qu'il a une sensation de sable dans les yeux? Est-ce qu'il met des larmes artificielles? Est-ce qu'il a besoin de boire beaucoup d'eau pour passer le bol alimentaire, dans les cas les plus sévères? Et est-ce qu'il a une fluxion des glandes salivaires, telles que, par exemple, les parotides? Là, vous avez le SDAI, c'est un indice d'activité du syndrome de Gougeron, où il existe des signes cliniques, tels que, par exemple, la fièvre, la perte du poids, l'existence d'adénopathie, de fluxion glandulaire, d'arthrite, d'atteinte cutanée, pulmonaire, rénale, du système nerveux, d'atteinte hématologique et aussi une atteinte biologique qu'on verra tout à l'heure, telle que l'existence d'une hypergammaglobulinémie, d'une baisse du complément sérique. Et donc, tout ceci pour permettre de classer le rapport sur le diagnostic du syndrome de Gougeron-Joplin. Alors, vous avez les critères d'inclusion qu'on a cités tout à l'heure, au moins un critère subjectif ou alors un critère objectif parmi les éléments qu'on a vus dans la plaque précédente et associé à une biopsie des glandes salivaires accessoire positive avec une cotation de 3, des anticorps anti-SSA positifs, une cotation de 3, donc une atteinte ophtalmologique soit par le Schirmer, soit par le Biesterfeld côté 1 et une stimulation du flux salivaire côté 1. Alors, quand on a plus de 4 critères, on peut faire le diagnostic d'un syndrome de Gougeron-Joplin.

(7:47 - 8:33)

Mais sur le plan pratique de tous les jours, on n'a pas besoin de tout ça pour faire le diagnostic et on peut faire le diagnostic chez un patient, par exemple, qui a une fluxion glandulaire, qui a des anti-SSA positifs, une biopsie des glandes salivaires, qui parle d'un stade 3 ou 4 de schizome sans pour autant que le patient présente les 4 critères. Je rappelle aussi que ces critères sont faits pour homogénéiser les études. Alors, ceci pour introduire le cours sur le syndrome de Gougeron, qui est là aussi une maladie auto-immune caractérisée par une infiltration glandulaire par des lymphocytes et des plasmocytes.

(8:33 - 8:52)

Alors, toutes les glandes peuvent être retouchées. Sur le plan clinique, ça va se manifester par un syndrome buccal sec et une sécheresse lacrymale. On peut avoir aussi des manifestations systémiques, des arthralgies, une atteinte pulmonaire.

(8:52 - 9:18)

Alors, ce syndrome sec peut être primitif, isolé, non associé à une maladie de système ou alors secondaire à une maladie de système telle que le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. Telle que le cas qu'on a vu tout à l'heure. Sur le plan épidémiologique, c'est une infection qui fréquente chez la femme comme le lupus systémique, mais l'âge moyen de survenue, c'est un âge qui est un petit peu avancé par rapport au lupus.

(9:18 - 11:14)

Donc, au niveau de la quatrième décennie, il existe des formes familiales comme toutes les maladies de système avec une prédisposition génétique. Pour le diagnostic de cette infection, vous avez les circonstances de découverte, soit que le patient vient consulter parce qu'il a des manifestations de syndrome sec oculaire et buccal, soit alors c'est une glondulaire au niveau des parotides ou il peut s'agir de manifestations extra glondulaire comme l'existence d'arthralgies inflammatoires, d'une manifestation biologique telle qu'une V.S. très accélérée ou alors une hypergamma polyclonale. Les manifestations cliniques, alors vous avez des manifestations glondulaire et des manifestations extra glondulaire dans les manifestations glondulaire, vous avez les manifestations salivaires telles que la xerostomie dont on a parlé tout à l'heure, c'est la sensation de bouche sèche.

(11:15 - 11:57)

Qui va gêner la parole et la déglutition et le patient est obligé de prendre de l'eau pour parler ou alors de faire passer le bol alimentaire. Ces manifestations de bouche sèche peuvent exister aussi la nuit, le patient se réveille pour boire et ça peut s'accompagner de fissurations douloureuses et d'infections. Les signes physiques, quand on va faire un examen de la cavité buccale, on va voir que les lèvres sont sèches, que la langue est décapillée, les muqueuses sont ternes, ça peut se compliquer de caries, de stomatites et de candidose buccale.

(12:01 - 12:23)

Alors voici un syndrome sec buccal avec une langue qui est décapillée et des lèvres qui sont sèches. Et là vous avez une image de fluxion parotidienne unilatérale. Là vous avez une parotidomégalie bilatérale.

(12:27 - 12:50)

Parmi les manifestations ophtalmologiques, on peut avoir une sensation de corps étranger, de sable au niveau des yeux et des brûlures ophtalmologiques en rapport avec une absence de larmes. Souvent, les patients se réveillent avec des paupières collées le matin et avec des sécrétions très épaisses. C'est très désagréable.

(12:51 - 13:32)

Parmi les complications, on peut avoir une keratoconjonctivite sèche, un ulcère corneillant ou alors une perforation corneillante. Et là, c'est des lésions sur lesquelles il y aura une fixation très importante du verre de lysamine. Par rapport à l'atteinte des autres glandes, on peut avoir une atteinte de la muqueuse génitale responsable d'une dyspareunie, une atteinte de la muqueuse de la peau responsable d'une xerodermie, des muqueuses digestives avec une oesophagie, une gastrite atrophique et une insuffisance pancréatique exocrine.

(13:32 - 14:09)

L'atteinte des voies aériennes est responsable d'une toux irritative, de sensations de gorge sèche et de laryngotraquéite. Quelles sont les autres atteintes que vous devez rechercher chez votre patiente? Il y a l'atteinte dermatologique qui existe dans 16% des cas. Souvent, c'est un purpura vasculaire, c'est-à-dire un purpura non thrombopénique caractérisé par l'existence de ces lésions pétiécales qui peuvent confluer et qui sont un petit peu en relief par rapport à la surface cutanée.

(14:11 - 14:38)

On peut avoir un érythème noueux également. D'autres atteintes systémiques ou alors d'autres atteintes dermatologiques telles que le guivert d'eau réticulaire comme vous le voyez ici. Donc, c'est une atteinte de la micro-circulation sous la peau sous forme d'arbre et un phénomène de rhénopie qui se voit dans 20 à 40% des cas.

(14:38 - 15:00)

Et là, on n'a pas d'anomalie capillaroscopique. On verra les anomalies capillaroscopiques quand on verra le cours sur la sclérodermie systémique. L'atteinte neurologique centrale peut se manifester par un déficit moteur, une paraparésie, une paraplégie, une hémiparésie.

(15:00 - 15:27)

On peut avoir des syndromes extrapyramidaux, une démence, une méningite aseptique, une atteinte de la moelle avec l'existence d'une myélite transverse par exemple. Alors, ce qui va nous permettre de faire le diagnostic, bien sûr, c'est le faisceau d'arguments cliniques. Mais on fait une IRM en céphalique qui est objective des hypersignaux T2 au niveau de la substance blanche.

(15:27 - 15:46)

Et ceci peut faire le diagnostic différentiel avec une sclérose ample. Parmi les manifestations psychiatriques, le syndrome dépressif est très, très fréquent avec une hypochondrie. Et les malades sont souvent des patients qui ont une mauvaise qualité de vie et qui souffrent tout le temps.

(15:49 - 16:17)

Alors, voici une image d'hypersignaux au niveau de la substance blanche chez un patient qui a un syndrome de Gouffreau-Chagrin. Là, vous avez des hypersignaux au niveau modulaire cérébral. Et on peut avoir également une atteinte neurologique périphérique.

(16:20 - 16:36)

Toutes les formes de neuropathie périphérique peuvent être observées au cours du lupus systémique. Soit une atteinte polyneuropathique qui peut être sensitive ou motrice, symétrique. Soit une neuropathie sensitive pure qui est très grave.

(16:36 - 16:59)

Et il n'y a pas beaucoup de ressources thérapeutiques pour cette forme de neuropathie. On peut avoir une atteinte du trijumeau très douloureuse, très caractéristique. Une paralysie faciale périphérique avec une atteinte du SET et des syndromes du canal carpien par infiltration lymphoplasmositaire du canal carpien.

(17:02 - 17:31)

Une atteinte tracheo-branchique et pulmonaire. On a dit tout à l'heure qu'on peut avoir une toux persistante, une dyspnée, une alvéolite lymphocytaire au niveau du LBA, du lavage broncho-alvéolaire quand on a une atteinte pulmonaire. Alors, ça peut se compliquer de complications infectieuses telles qu'une pneumopathie Fransch-Laubert aiguë ou alors une pneumopathie à germe intracellulaire.

(17:31 - 17:52)

Et une fibrose interstitielle diffuse est observée chez 5% des patients. Là, vous avez une image de fibrose interstitielle diffuse chez un patient qui a un syndrome de Gougerot-Chograin. Une atteinte rénale peut être observée.

(17:53 - 18:12)

Alors, souvent, c'est une atteinte tubulaire distale. Ce n'est pas une atteinte glomérulaire comme dans le cadre du lupus systémique. Alors, ça se manifeste par un défaut de concentration des urines, une acidose hyperchlorémique au niveau de l'ionogramme sanguin, une hypocalcémie dans les cas très graves.

(18:13 - 18:25)

Et alors, cette hypocalcémie est secondaire à la fuite urinaire du potassium. Ça peut se manifester par des crampes musculaires et aussi une paraplégie. Et au final, une litière urinaire avec un tableau d'insuffisance rénale.

(18:28 - 18:42)

Alors, pour ce qui est des autres atteintes, vous avez l'asthénie qui est quasi constante. Ces patients, on a dit qu'ils ont une mauvaise qualité de vie. Ils souffrent beaucoup.

(18:42 - 19:02)

L'atteinte rhumatologique sous forme d'arthralgie inflammatoire ou demi-allergie. Et puis, des signes en rapport avec la simulation du système immunitaire, tels que les anopathies et une splénomégalie qui peuvent aussi être le témoin d'un lymphome. Parce que la complication lymphomateuse est fréquente chez ces patients là.

(19:06 - 19:25)

Alors, on revient à notre cas clinique. Le bilan biologique chez notre patiente montre une vitesse de sédimentation accélérée, une CRP à 5 mg par litre. Comment expliquez-vous ces résultats? Le fait que cette vitesse de sédimentation soit accélérée avec une CRP qui n'est pas très augmentée.

(19:29 - 19:44)

Alors, voici un diapo qui vous montre les valeurs normales de la vitesse de sédimentation. Alors, quand on est inférieur à 50 ans et qu'il s'agisse d'une femme, c'est 20 mm. Quand l'âge est supérieur à 50 ans, c'est 30 mm.

(19:45 - 19:57)

Elle est plus basse chez l'homme. La vitesse de sédimentation. Alors là, vous avez une diapo qui montre les causes d'augmentation de la vitesse de sédimentation.

(19:59 - 20:16)

Alors, soit c'est une diminution des globules rouges, comme pour les anémies profondes. Mais là, la vitesse de sédimentation n'augmente pas beaucoup. Ou alors, c'est une augmentation des protéines de l'inflammation, telles que par exemple, dans le cadre des infections, des cancers, des nécroses.

(20:17 - 20:38)

Soit c'est une stimulation du système immunitaire, soit alors que c'est une gammaphatie polyclonale ou monoclonale. Et dans ce cadre, lorsque vous avez une accélération de la vitesse de sédimentation avec une CRP normale, il faut demander ce qu'on appelle une électrophorese des protéines CRP. Alors, électrophoreses des protéines CRP.

(20:39 - 21:07)

Là, vous avez le pic de l'albumine, l'alpha 1, l'alpha 2, bêta 1, bêta 2 globuline. C'est à dire que lorsque vous avez une vitesse de sédimentation accélérée avec une CRP normale, il peut y avoir une augmentation des gamma globuline qui, elle, est responsable de cette augmentation de la vitesse de sédimentation. C'est à dire vitesse de sédimentation accélérée ne va pas vouloir toujours dire syndrome biologique inflammatoire.

(21:09 - 21:39)

Alors, les examens biologiques qu'on demande dans le cadre du syndrome de Gaucherot-Chograin, c'est l'hémogramme qui peut montrer, comme dans le plus systémique, une leukopénie, une lymphopénie, une anémie et une thrombopénie qui sont d'origine auto-immu. Une accélération de la vitesse de sédimentation qui est liée à l'hypergamma polyclonale chez ces patients. Alors, les anomalies immunologiques, vous avez le facteur hématoïde positif dans 50 à 75% des cas.

(21:39 - 22:03)

Mais ce qui est plus caractéristique, c'est l'existence d'anticorps anti-SSA et secondairement, l'existence d'anticorps anti-SSB. Rappelez-vous la dernière fois que ces anticorps donnent une fluorescence mouchetée. Alors, le diagnostic différentiel peut se poser dans le cas du syndrome sec avec le vieillissement.

(22:04 - 22:30)

Quand on vieillit, on peut avoir un syndrome sec parce que les glandes salivaires ne secrètent pas beaucoup de salive et également les glandes lacrymoïdes. Ça peut être médicamenteux comme les bêtas bloquants, les codéines, la codéine et également les antidépresseurs. La sarcoïdose peut donner un syndrome sec, l'hépatite C, le VIH et la maladie du griffon contre l'autre.

(22:31 - 22:58)

La tumefaction des glandes salivaires peut se voir quand on a une amylose, une sarcoïdose ou alors une tumeur des glandes salivaires. L'évolution peut être bénie comme elle peut être marquée par la survenue d'un lymphome malin nonotchkien qui se voit dans 5 à 10% des cas. Ces lymphomes se localisent au niveau des glandes salivaires, de l'estomac et du poulmon.

(22:59 - 23:23)

Les facteurs prédictifs de la survenue d'un lymphome sont l'existence d'une parotidomégalie, surtout lorsqu'elle est unilatérale. L'existence d'unopathie de grande taille, une splénomégalie et une gammopathie monoclonale. C'est pour cette raison qu'il faut réexaminer ses patients à chaque fois et demander une électrophorèse des protéines sériques.

(23:23 - 23:56)

L'existence d'une cryoglobulinémie, d'une hypogamma, d'une élévation de la bêta de glycoprotéines et l'apparition de chaînes légères dans les urines. Alors, ces éléments peuvent être reproduits ou alors demandés à chaque fois chez les patients qui ont un syndrome de gauche-roche-jogaine. Autre complication, c'est le bloc auriculoventriculaire congénital qui se voit chez les fœtus des mamans qui sont porteuses d'anticorps anti-SSA, d'où la surveillance par échocardiographie fœtale chez les femmes enceintes.

(23:57 - 24:10)

Le traitement est basé sur le traitement symptomatique du syndrome sec. Pour l'acte 0, vous avez les larmes artificielles. Plusieurs spécialités sont commercialisées.

(24:10 - 24:46)

Dans tous les cas, il faut éviter les facteurs qui irritent la muqueuse oculaire, tels que la fumée, la chaleur et les lentilles de contact sont contre-indiquées. L'acte 0 stomie est traité par le salagès qui est un médicament dérivé de la pilocarpine qui n'est pas commercialisé au Maroc, qui est commercialisé en Turquie avec un prix beaucoup moins important qu'en France. La dose est de 5000 grammes x 4 par jour, c'est à dire un comprimé 4 fois.

(24:47 - 25:10)

Mais il y a des malades qui nécessitent moins, qui ont besoin de moins de comprimés par jour pour lutter contre la sécheresse du cal. Il y a la séville muline qui est qui ressemble un petit peu au salagène qui est commercialisé aux Etats-Unis. Et toujours, il faut insister sur l'hygiène buccodentaire pour ne pas avoir des surinfections dentaires à réputation.

(25:12 - 25:27)

Alors, le traitement de la composante systémique pour la parotidomégalie. On a recours à la corticothérapie de courte durée. On peut avoir aussi dans les cas résistants recours aux immunosuppresseurs comme le chloronducide ou la radiothérapie.

(25:27 - 25:48)

Comme c'est des parotidomégalies qui sont réfractaires et qui sont très importantes. Traitement

de la douleur, c'est par palier de l'OMS, c'est à dire les antalgiques, les anti-inflammatoires et puis on peut même des fois arriver au morphinique. La teinte articulaire est traitée par les anti-inflammatoires non stéroïdiens et par la corticothérapie à faible dose.

(25:49 - 26:07)

Également, on peut avoir recours à l'hydroxychloroquine et le méthotrexate dans les formes qui sont réfractaires au corticoïde. La pneumopathie interstitielle influide est traitée par corticothérapie et cyclophosphamie. Traitement de la composante systémique, toujours.

(26:08 - 26:19)

Pour la teinte neurologique centrale et périphérique, toujours le cyclophosphamie ou alors de l'inurel. Et pour les lymphomes, c'est la chimio et la radiothérapie.